BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN Phòng Điều dưỡng	QUY TRÌNH CHUẨN (SOP) QUY ĐỊNH XÁC ĐỊNH NGƯỜI BỆNH	Mã số: SOP-D2.4 Lần ban hành: 01 Ngày hiệu lực: …/…/2026 Số trang: theo bản in

	Người biên soạn	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Họ tên			
Chức danh	Điều dưỡng Phòng Điều dưỡng	Trưởng phòng Điều dưỡng	Giám đốc
Chữ ký			
Ngày			

Lần	Ngày	Nội dung sửa đổi
01		Ban hành lần đầu (chuẩn hóa từ file D2.4 của Phòng Điều dưỡng)

DỰ THẢO

1. Mục đích

Thống nhất việc xác định đúng người bệnh trong mọi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: đúng người bệnh, đúng dịch vụ, đúng thuốc, đúng thủ thuật; phòng ngừa sự cố do nhầm lẫn người bệnh.

2. Phạm vi

Người bệnh nội trú, ngoại trú, cấp cứu; mọi nhân viên y tế tham gia khám, điều trị, chăm sóc, thực hiện dịch vụ kỹ thuật, tiếp đón, đăng ký tại các khoa, phòng.

3. Định nghĩa

- Xác định người bệnh: kiểm tra, đối chiếu thông tin để bảo đảm người được thực hiện dịch vụ đúng là người bệnh cần thực hiện.
- Thông tin nhận dạng (dùng tối thiểu 02): họ và tên; ngày tháng năm sinh; mã người bệnh hoặc mã hồ sơ bệnh án; số định danh cá nhân.
- Không dùng làm thông tin nhận dạng: số giường, vị trí buồng bệnh, chẩn đoán, nhìn mặt quen.

4. Trách nhiệm

Chức danh	Trách nhiệm
Bác sĩ	Xác định đúng người bệnh trước khám, chỉ định, điều trị, thủ thuật
Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên	Kiểm tra nhận dạng trước mọi can thiệp chăm sóc, dùng thuốc, lấy mẫu, truyền máu; đeo vòng nhận dạng khi nhập khoa
Nhân viên tiếp đón, đăng ký	Nhập đúng thông tin hành chính, đối chiếu giấy tờ tùy thân; đọc lại cho

Chức danh	Trách nhiệm
	người bệnh xác nhận
Khoa Dược	Phối hợp kiểm soát cấp phát thuốc đúng người bệnh
Trưởng khoa, Điều dưỡng trưởng	Giám sát tuân thủ theo Điều 2 Quyết định ban hành
Phòng Điều dưỡng, Phòng QLCL	Giám sát độc lập, phân tích sự cố, cải tiến

5. Nguyên tắc

1. Luôn dùng tối thiểu 02 thông tin nhận dạng.
2. Hỏi câu mở, người bệnh tự nói: "Anh/chị vui lòng cho biết họ tên và ngày sinh"; không hỏi câu đóng kiểu "Có phải bác tên A không?".
3. Không xác định người bệnh dựa vào số giường, vị trí buồng hay nhìn mặt quen.
4. Mọi hoạt động nguy cơ cao phải xác nhận lại danh tính, kể cả khi đã xác định trước đó trong ca.
5. Người bệnh nội trú đeo vòng nhận dạng từ khi nhập khoa đến khi ra viện; vòng hỏng, mờ, sai phải thay ngay.

6. Thời điểm bắt buộc xác định người bệnh

Khi tiếp nhận, đăng ký; trước dùng thuốc; trước lấy máu, lấy mẫu bệnh phẩm; trước truyền máu và chế phẩm máu; trước xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng; trước phẫu thuật, thủ thuật; trước vận chuyển, bàn giao người bệnh; khi báo kết quả, báo dịch, chuyển viện; trước mọi can thiệp điều trị.

7. Các bước thực hiện

Bước	Nội dung	Người thực hiện
1. Chuẩn bị	Tiếp cận người bệnh; kiểm tra vòng nhận dạng; chuẩn bị hồ sơ, phiếu chỉ định	Nhân viên y tế
2. Xác định	Đề nghị người bệnh tự nói họ tên, ngày sinh; đối chiếu hồ sơ, phiếu chỉ định, vòng nhận dạng; đủ ít nhất 02 thông tin khớp	Nhân viên y tế
3. Xác nhận dịch vụ	Đọc lại tên, nói dịch vụ sẽ thực hiện, giải thích ngắn gọn	Nhân viên y tế
4. Thực hiện	Chỉ làm khi thông tin khớp; có sai lệch thì dừng ngay, xác minh lại, báo người phụ trách	Bác sĩ, ĐD, KTV
5. Ghi nhận	Ghi hồ sơ; báo cáo sự cố hoặc suýt sự cố bằng BM-D2.4-02 khi phát hiện nhầm lẫn hoặc nguy cơ nhầm lẫn	Người thực hiện

8. Trường hợp đặc biệt

Trường hợp	Cách xác định
Hôn mê, mất ý thức, không giao tiếp được	Vòng nhận dạng, hồ sơ bệnh án, người nhà hoặc người giám hộ hợp pháp, thông tin tiếp nhận ban đầu
Chưa rõ danh tính (cấp cứu)	Đặt mã tạm theo quy định tiếp nhận cấp cứu, ghi giới, ước tuổi, giờ

Trường hợp	Cách xác định
	vào viện; cập nhật ngay khi có thông tin
Trẻ sơ sinh	Vòng nhận dạng mẹ và bé, họ tên mẹ, mã hồ sơ, ngày giờ sinh, giới
Trẻ em	Hỏi cha mẹ hoặc người chăm sóc, đối chiếu vòng nhận dạng
Trùng tên, gần trùng tên trong khoa	Ghi cảnh báo "TRÙNG TÊN" trên bảng theo dõi, hồ sơ; xếp khác buồng nếu được; bắt buộc đối chiếu thêm mã người bệnh
Người nước ngoài, bất đồng ngôn ngữ	Dùng giấy tờ tùy thân, người phiên dịch hoặc người nhà; đối chiếu vòng nhận dạng

9. Kiểm soát rủi ro

Rủi ro	Nguyên nhân thường gặp	Biện pháp
Nhầm người bệnh	Không đối chiếu, hỏi câu đóng	Bắt buộc 02 thông tin, câu hỏi mở
Nhầm mẫu xét nghiệm	Dán nhãn sai, dán trước khi lấy mẫu	Dán nhãn tại giường ngay sau khi lấy mẫu
Nhầm thuốc	Bỏ bước xác nhận	Nguyên tắc 5 đúng; 3 kiểm tra 5 đối chiếu
Nhầm thủ thuật	Không kiểm tra trước thủ thuật	Time-out, bảng kiểm an toàn
Sai thông tin hành chính	Nhập liệu khi đăng ký	Đọc lại cho người bệnh xác nhận; đối chiếu giấy tờ

10. Theo dõi, đánh giá

- KPI-D2.4-01: Tỷ lệ tuân thủ xác định người bệnh (giám sát độc lập) ≥ 95%.
- KPI-D2.4-02: Tỷ lệ người bệnh nội trú đeo vòng nhận dạng đúng ≥ 98%.
- KPI-D2.4-03: Tỷ lệ truyền máu được 02 nhân viên y tế cùng xác nhận 100%.
- KPI-D2.4-04: Tỷ lệ phẫu thuật, thủ thuật có thực hiện time-out 100%.
- KPI-D2.4-05: Số sự cố nhầm người bệnh gây hại 0.
- KPI-D2.4-06: Số suýt sự cố nhận dạng được báo cáo ≥ 2 báo cáo/tháng toàn viện.
- KPI-D2.4-07: Tỷ lệ khoa có giám sát độc lập đủ cỡ mẫu trong tháng 100%.

Tần suất: hằng tháng tại khoa và Phòng Điều dưỡng; hằng quý Phòng Quản lý chất lượng; rà soát quy định tối thiểu 02 năm một lần.

11. Căn cứ

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 (Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH).
- Thông tư số 43/2018/TT-BYT hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.
- Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 (Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam).

Ghi chú: *File gốc của Phòng dẫn Thông tư 19/2013/TT-BYT; văn bản này dùng các căn cứ trên. Quy định truyền máu của Bộ Y tế cần xác minh số hiệu còn hiệu lực trước khi bổ sung vào căn cứ.*